SUPSI

Disabilità intellettiva (disturbo dello sviluppo intellettivo)

Chiara Balerna, Michela Luraschi, Donatella Oggier –Fusi, Piercarla Reposo

Cosa è la disabilità intellettiva?

- La disabilità intellettiva è caratterizzata da limitazioni significative sia nel funzionamento intellettivo sia nel comportamento adattivo, che si manifestano nelle abilità adattive concettuali, sociali e pratiche. Tale disabilità ha origine durante il periodo dello sviluppo, definito operativamente come il periodo precedente il compimento dei 22 anni di età

(AAIDD, 2022, p.29)

Disabilità intellettiva - precisazioni

Per l'applicazione delle definizione, sono necessari cinque assunti:

- Le limitazioni nel funzionamento presente devono essere considerate all'interno del contesto degli ambienti comunitari tipici per età e cultura dell'individuo
- Una valutazione efficace considera i fattori culturali e linguistici, così come le differenze nella comunicazione e nei fattori sensoriali, motori e comportamentiali
- In una stessa persona le limitazioni spesso coesistono con i punti di forza
- Un obiettivo fondamentale nella descrizione delle limitazioni è quello di sviluppare un profilo dei sostegni necessari
- Con un adeguato sistema individualizzato di sostegni, forniti per un periodo prolungato, il funzionamento della persona con deficit intellettivo generalmente tende a migliorare

(AAIDD, 2022, p.30)

A. Funzionamento intellettivo

- Funzionamento intellettivo è un termine più ampio rispetto a quello di intelligenza e di abilità intellettive ma più ristretto rispetto a funzionamento umano.
- Le limitazioni nel funzionamento intellettivo si traducono tipicamente in difficoltà nel pensare e nell'apprendere, nel ragionare e nel pianificare e nell'imparare dall'esperienza
- Per stabilire le limitazioni significative nel funzionamento intellettivo, dovrebbe essere usato un punteggio del QI totale. L'intelligenza generale, e di conseguenza il funzionamento intellettivo, è più accuratamente valutato e rappresentato utilizzando un test affidabile, valido, somministrato individualmente, completo e standardizzato che produce un test del QI totale.
- Per una diagnosi di DI, il criterio corrisponde a un punteggio del QI totale approssimativamente due o più deviazioni standard sotto la media ovvero un QI inferiore a 70-75

TABELLA 3.1

Esempi di limitazioni significative nel funzionamento intellettivo

Area di funzionamento	Esempi di limitazioni significative
Pensiero e apprendimento	• Difficoltà nella risoluzione di problemi, nel pensiero astratto, nella comprensione di idee complesse, nell'apprendimento rapido e nell'apprendere dall'esperienza
Ragionamento e pianificazione	• Difficoltà nella pianificazione e nell'applicazione • Ridotte competenze interpersonali e capacità decisionali • Difficoltà nella risoluzione di problemi sociali e nel pensiero flessibile
Apprendimento dall'esperienza	• Difficoltà nel generalizzare l'apprendimento da precedenti esperienze e situazioni • Aumentata vulnerabilità e/o rischio di essere vittima di raggiro o azioni/comportamenti malevoli • Tendenza a negare o minimizzare la propria disabilità • Desiderio di compiacere la figura di autorità • Possibile ingenuità, credulità e/o suggestionabilità

B. Comportamento adattivo

Il comportamento adattivo si può definire come l'insieme di abilità concettuali, sociali e pratiche, che sono state apprese dalle persone per il funzionamento nella loro vita quotidiana

Il comportamento adattivo è

– Evolutivo e aumenta di complessità con l'età

– Composto da abilità concettuali, sociali e pratiche

– Legato alle aspettative dell'età e alle richieste di particolari contesti

– Valutato sulla base delle prestazioni tipiche dell'individuo a casa, a scuola, al lavoro e nel tempo libero, e non sulla prestazioni migliore

– Valutato in riferimento agli ambienti di vita nella comunità tipici per l'età

Per una diagnosi di DI il criterio corrisponde a un punteggio di comportamento adattivo approssimativamente due o più deviazioni standard sotto la media in almeno uno dei tre domini di comportamento adattivo: concettuale, sociale o pratico

TABELLA 3.3

Esempi di limitazioni significative nel comportamento adattivo

Dominio di comportamento adattivo	Esempi di limitazioni significative
Abilità concettuali	• Ridotta pianificazione indipendente, risoluzione dei problemi o pensiero astratto • Difficoltà a scegliere una buona soluzione di fronte a un problema o una situazione • Difficoltà a usare efficacemente idee o simboli, come il tempo e le funzioni matematiche • Difficoltà a comunicare efficacemente pensieri o idee • Difficoltà nella gestione di sé e/o nell'organizzare o pianificare le attività della vita futura • Difficoltà ad anticipare le conseguenze del proprio comportamento • Difficoltà negli studi (lettura, scrittura, aritmetica) • Difficoltà con il denaro/con i concetti economico-finanziari
Abilità sociali	• Compromissione delle abilità sociali-interpersonali e nell'apprendimento attraverso l'esperienza • Difficoltà a lavorare efficacemente con gli altri per la risoluzione di gruppo dei problemi • Pensiero e comportamento inflessibile e concreto durante situazioni sociali complesse • Maggiore vulnerabilità e rischio di vittimizzazione, specialmente riguardo a chi ci si può affidare, chi seguire e quali circostanze sono sicure • Risposta sociale e giudizio sociale inadeguati • Tendenza a negare o minimizzare la disabilità a loro danno • Forte desiderio di compiacere le figure di autorità basato su una limitata comprensione della situazione • Credulità, ingenuità e suggestionabilità nelle interazioni con gli altri
Abilità pratiche	• Limitazioni nella cura di sé e nelle abilità domestiche • Limitazioni nelle abilità lavorative come ottenere un lavoro stabile che copra le spese, esercitare le competenze lavorative, cooperare con i colleghi e i superiori, gestire i conflitti di lavoro in modo appropriato, mantenere un lavoro di alta qualità sotto pressione • Limitazioni nell'uso del denaro (ad esempio, dare il resto, comprendere il valore della moneta, pagare le bollette) e della proprietà (ad esempio, concedere «prestiti» a persone che non ripagano, cedere proprietà o diritti, fare acquisti non conformi al proprio bilancio/mezzi) • Limitazioni nel mantenere un ambiente sicuro in relazione a se stessi e ai propri figli, prodotti per la pulizia della casa, conservazione del cibo, medicine/farmaci, o usare cautela o proteggere gli altri dalla corrente elettrica, dai veicoli e dai macchinari

(Immagine presente
in piattaforma da scaricare)

C. Età di esordio

- La maggioranza delle diagnosi di Deficit intellettivo sono fatte nella prima infanzia.

- Per una diagnosi di Deficit intellettivo, il criterio dell'età di esordio richiede che la disabilità abbia origine durante il periodo di sviluppo, definito operativamente come il periodo precedente il compimento dei 22 anni di età

Disabilità intellettiva e ritardo mentale

- Il termine «deficit intellettivo» riguarda la stessa popolazione di individui che erano diagnosticati come persone con un ritardo mentale

- L'espressione «disabilità intellettive» vuole sostituire integralmente l'espressione «ritardo mentale» in quanto ritenuta più adeguata a descrivere esattamente gli stessi fenomeni

- L'espressione «ritardo mentale» sottolinea che lo sviluppo di alcuni individui è caratterizzato da uno sviluppo più lento di quello tipico. Questo ritardo implica anche differenze qualitative e i traguardi cognitivi finali sono comunque inferiori rispetto a quelli tipici; questo sembra sufficiente per invitare a non utilizzare questa espressione.

Disabilità intellettive e disabilità cognitive

- Con l'espressione disabilità cognitive ci si riferisce a qualcosa di più ampio, in quanto si considerano anche disabilità non intellettive come i disturbi dell'apprendimento o le carenze cognitive tipiche di individui con sindrome di Asperger e normale intelligenza.

- Analogamente non ci sono dubbi che disturbi dell'attenzione, delle capacità di concentrarsi e di memoria siano disabilità cognitive. Non sempre esse sono disabilità intellettive, in quanto non sempre comportano prestazioni inferiori in test di intelligenza.

- Infine possiamo sottolineare che anche le disabilità sensoriali potrebbero rientrare nelle disabilità cognitive (ma non in quelle intellettive), in quanto comportano carenze nelle conoscenze percettive

Il concetto di QI - storia

- Nel 1904, il ministero della Pubblica Istruzione francese incarica una commissione di studiare dei metodi per l'educazione dei bambini delle scuole di Parigi che presentavano uno sviluppo intellettivo subnormale: si pensava che se fosse stato possibile accoglierli in scuole speciali, quei bambini incapaci di seguire il normale percorso di studi, avrebbero potuto raggiungere risultati migliori. Della commissione faceva parte anche Binet.
- Essendo il primo problema da risolvere quello della individuazione dei soggetti mentalmente più limitati, Binet e i suoi collaboratori, dopo aver trascorso un gran numero di ore tra i bambini delle scuole, osservando e sottoponendo loro dei quesiti di vario tipo, elaborarono la prima scala metrica. La scala era composta da una serie di 30 problemi o **test**, che si proponevano di offrire una valutazione di alcuni aspetti dell'intelligenza, come la capacità di comprensione, di ragionamento logico e di giudizio. I problemi erano stati scelti in modo da ridurre al minimo il riferimento alle nozioni scolastiche

Il concetto di QI - storia

- Nel 1905 Alfred Binet con Theodore Simon pubblica “L’échelle de l’intelligence - Binet-Simon “ una scala di valutazione realizzata con l’intento principale di identificare chi, per la scuola dell’obbligo, presentasse necessità diverse da altri per affrontare le diverse materie scolastiche.

- Il test misurava l'età mentale del bambino in modo che un bambino di 7 anni che risolvesse i problemi che in media risolvevano i bambini di 7 anni, ottenesse un punteggio di 7.
- La qualificazione di **debile** o di **ritardato mentale** è applicata in quel periodo a individui sufficientemente educabili per giungere al termine dello sviluppo (fissato allora ai 15 anni), all'acquisizione della lettura e della scrittura (che corrisponde al livello di uno scolaro di 7-8 anni), ma incapaci di raggiungere il pensiero astratto (11 anni).
- Binet è considerato il padre della psicometria

Il concetto di QI - storia

- In questo strumento l'insieme degli item (="esercizi"/prove) superati dava la misura dell'età mentale. Il ritardo dello sviluppo intellettivo era misurato dallo scarto tra età cronologica e età "attesa"

- Ad esempio un bambino di 7 anni ha un'età mentale di 9 se risolve compiti risolti generalmente a 9 anni

Il concetto di QI - storia

- Uno dei concetti fondamentali introdotti da Binet per la valutazione dei risultati dei test è quello di **età mentale**, Secondo tale concetto, un bambino è dotato di un'intelligenza corrispondente ai tre anni se riesce a risolvere la metà dei test risolti normalmente dai bambini di quell'età; l'intelligenza corrisponde ai 4 anni se il bambino supera almeno la metà dei test preparati per un'età di quattro anni, e così via.
  Come misura del **ritardo mentale**, Binet utilizzava la semplice differenza tra l'età mentale del bambino e la sua età cronologica. Tale sistema era però poco pratico, perché non rendeva bene l'idea dell'entità del ritardo. Infatti, uno scarto di 2 anni a un'età di 5 anni, indicava un limite intellettivo molto serio, mentre le stesso ritardo conteggiato, ad esempio, in un ragazzo di 14 anni, rappresentava uno svantaggio molto più lieve.

Il concetto di QI - storia

- Dopo la morte di Binet, tale problema venne superato utilizzando, invece della differenza, il **rapporto** tra l'età mentale e l'età cronologica. Tale rapporto, moltiplicato per 100 (e depurato di eventuali decimali) è quello che viene comunemente chiamato **QI** (*quoziente di intelligenza → il quoziente in matematica è il risultato di una divisione*).

- Il termine di quoziente intellettivo si deve a Stern che intende in tal modo evidenziare un rapporto (stabile e predittivo) fra età mentale e età cronologica:

$$QI = \frac{Età\ mentale}{Età\ cronologica} \cdot 100$$

Il concetto di QI

- Il **quoziente d'intelligenza** o **QI** è un punteggio ottenuto sulla base di strumenti detti psicometrici (test standardizzati capaci di misurare alcune forme di espressione dell’intelligenza). Il QI ha la pretesa di predire lo sviluppo intellettuale dell'individuo sulla base dei risultati osservati (prognosi) e confrontati alla distribuzione generale normale dei risultati di una popolazione data osservati nelle stesse condizioni (curva di Gauss).

Scala Stanford-Binet per la misurazione del QI

- La scala subì svariate modifiche; l'attuale versione è la cosiddetta Stanford-Binet che permette di individuare il Quoziente Intellettivo (QI), cioè il rapporto tra età mentale (EM), misurata col test, ed età cronologica (EC), ovvero l'effettiva età del soggetto, moltiplicato per cento (per evitare i decimali) (De Luca, 1974).

(età mentale/età cronologica) x 100.

Esempi:

- Età mentale 12 anni – età cronologica 10anni QI=(12/10)x100=120
- Età mentale 10 anni – età cronologia 12anni QI=(10/12)x100=83

Il Quoziente Intellettivo

- Il QI esprime come le capacità intellettive di un soggetto si collocano rispetto ai propri coetanei in un continuum dove la prestazione media cade sul punteggio 100.
- Rappresenta una misura della deviazione della prestazione individuale rispetto alla media del gruppo d'età di appartenenza del soggetto.
- Viene misurato con una scala psicometrica standardizzata sulla popolazione di appartenenza del soggetto.
- Questa tradizionale valutazione si basa su distribuzione statistica dei punteggi QI, con Media 100 e Deviazione Standard 15.
- La maggior parte dei soggetti ottiene punteggi tra 85 e 115. Perciò statisticamente la "norma" rientra in questo range.

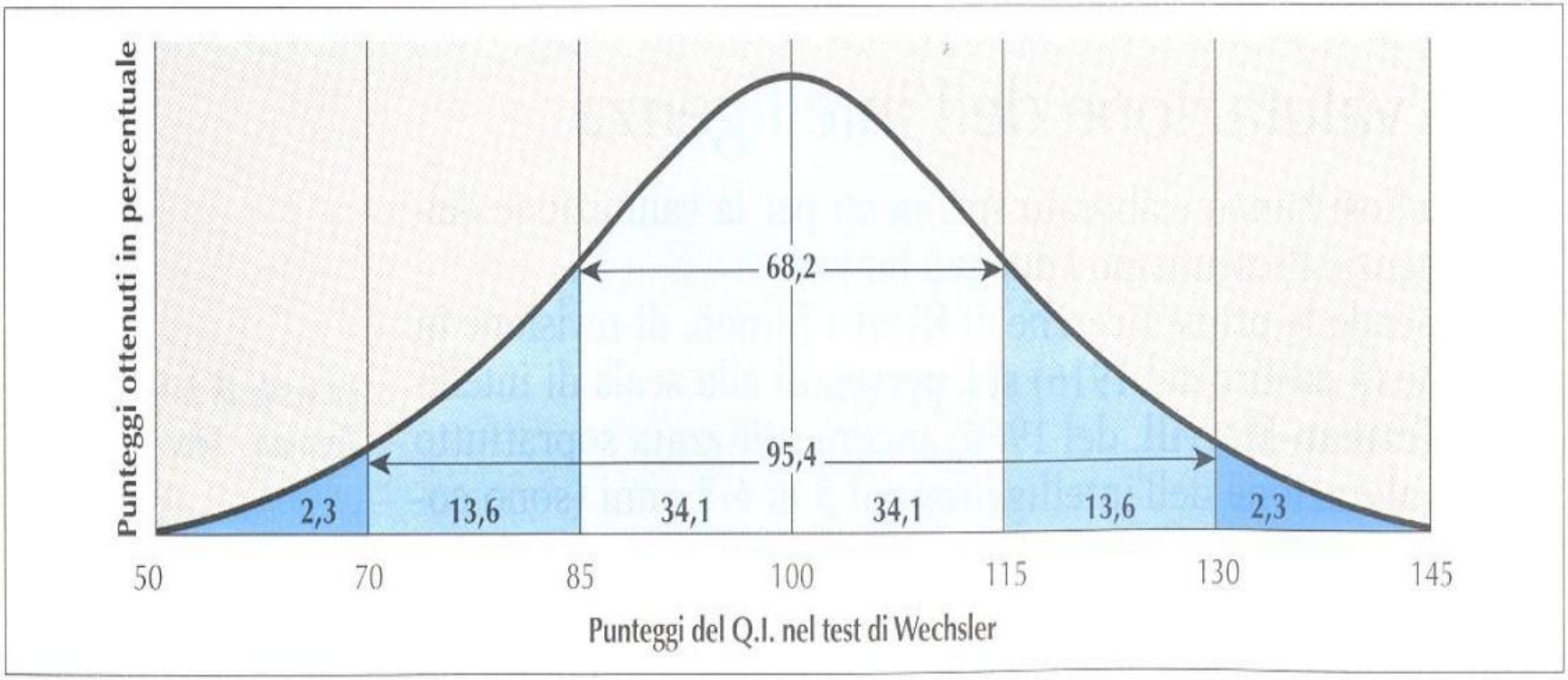

Fig. 3.2 Punteggi del Q.I. (quelli di riferimento) nel test di Wechsler.

Limiti del QI

- il dato numerico dice poco (quasi nulla) sulle abilità della persona e non da alcuna indicazione di riferimento specifica e significativa per i prossimi passi da intraprendere. Da questo punto di vista, qualsivoglia approccio valutativo di tipo funzionale da maggiori indicazioni rispetto al dato relativo sulla curva di Gauss; per altri scopi, fra cui il diritto a prestazioni, tale riscontro può essere necessario (richiesto).
- la valutazione dello sviluppo intellettuale con le prove classiche (come quelle di Wechsler) impone di non dare semplicemente un dato cifrato. Si rende necessaria un'analisi approfondita del profilo delle produzioni ottenute, come pure del risultato ad ogni singola prova, in modo da precisare l'estensione e la caratterizzazione delle abilità e dei deficit. Importa di più il profilo delle abilità in educazione che la posizione rispetto alla norma.
- i test d'intelligenza classici non permettono di valutare persone con ritardo globali importanti o differenze evolutive marcate. In questo caso si farà ricorso ad altri strumenti di valutazione (Utzgiris e Hunt, Dunst, …) .

Disabilità intellettiva – classificazione

La classificazione nell'ambito della disabilità intellettiva è uno schema organizzativo aggiuntivo post-diagnosi che usa un quadro di riferimento esplicito e un processo sistematico per suddividere il gruppo di individui con disabilità intellettiva in gruppi più piccoli

Lo schema di classificazione preferenziale dei sottogruppi di basa sull'intensità dei bisogni di sostegno

Classificazione basata sul QI	**Livello di intensità dei bisogni di sostegno**
Gravissima (0-20/25)	Continuo
Grave (20/25-40/45)	Estensivo
Medio/medio Grave (40/45-50/55	Limitato
Leggera/Lieve (50/55-70/75)	Intermittente

Prevalenza

- Studi diversi hanno riportato tassi diversi a seconda delle definizioni usate, deimetodi di valutazione e della popolazione studiata.
- I dati del DSM-V concordano su una stima dell'1%-1,5% nella popolazione generale; questo dato risulta il più accreditato

Eziologie

- Il deficit intellettivo ha diverse eziologie e può essere visto come la via finale comune di vari processi patologici che agiscono sul funzionamento del sistema nervoso centrale (DSM-IV)

Eziologie

- 30% alterazioni precoci dello sviluppo dell'embrione
- 10% problemi durante la gravidanza e nel periodo perinatale
- 5% causa ereditaria
- 5% condizioni mediche generali acquisite durante l'infanzia e la fanciullezza
- 15-20% influenze ambientali e altri disturbi mentali
- 30-40% causa sconosciuta

Fattori di rischio – cause

Periodo	Biomedico	Sociale	Comportamentale	Educativo
Prenatale	1. Anomalie cromosomiche 2. Alterazioni del singolo gene 3. Sindromi 4. Disturbi del metabolismo 5. Alterazioni dello svilupppo cerebrale (Disgenesie) 6. Malattie della madre 7. Età dei genitori	1. Povertà 2. Malnutrizione della madre 3. Violenza domestica 4. Mancato accesso alle cure prenatali	1. Uso di sostanze stupefacenti da parte dei genitori 2. Uso di alcool da parte dei genitori 3. Genitori fumatori 4. Immaturità dei genitori	1. Disabilità cognitiva dei genitori non accompagnata da sostegno 2. Mancanza di preparazione alla condizione genitoriale

Fattori di rischio – cause

Periodo	Biomedico	Sociale	Comportamentale	Educativo
Perinatale	1. Prematurità 2. Danni causati alla nascita 3. Disturbi neonatali	1. Mancato accesso alle cure perinatali	1. Rifiuto genitoriale dell'accudimento del figlio 2. Abbandono genitoriale del figlio	1. Mancanza di indicazioni mediche all'utilizzo dei servizi al momento della dimissione

Fattori di rischio – cause

Periodo	Biomedico	Sociale	Comportamentale	Educativo
Postnatale	1. Traumi cerebrali 2. Malnutrizione 3. Meningoence-falite 4. Disturbi convulsivi 5. Disturbi degenerativi	1. Problemi nella relazione bambino-operatore 2. Mancanza di un'adeguata stimolazione 3. Situazione di povertà familiare 4. Malattie croniche familiari 5. Istituzionaliz-zazione	1. Abuso e rifiuto del figlio 2. Violenza domestica 3. Misure di sicurezza inadeguate 4. Deprivazione sociale 5. Comportamenti problematici del bambino	1. Inadeguatezza del ruolo genitoriale 2. Diagnosi tardive 3. Servizi di primo intervento inadeguati 4. Servizi di educazione speciale inadeguati 5. Sostegno alla famiglia inadeguato

I Sistemi di Sostegno

Obiettivi:

- Permettere agli studenti di riconoscere le varie tipologie di sostegno di cui una persona può beneficiare, sottolineando l'ottica bio-psico-sociale già vista con l'ICF e CDPD;
- Comprendere come la valutazione o assesment del funzionamento e delle disabilità tramite ICF abbia lo scopo di progettare e pianificare un sistema di sostegni;
- Comprendere che grazie ad una rete adeguata di sostegni il funzionamento della persona con disabilità intellettiva migliora, così come la sua partecipazione sociale e la sua qualità di vita;
- Riflettere sul ruolo dell'operatore sociale

I Sistemi di sostegno

- Due presupposti essenziali:
  a. Uno scopo importante della descrizione delle limitazioni è quello di sviluppare un profilo di sostegni necessari
  b. Con adeguati sostegni personalizzati, sostenuti nel tempo, il funzionamento della persona con DI di solito tende a migliorare

- I sistemi di sostegno sono costruiti intorno a **valori** (promozione di opportunità per migliorare lo sviluppo personale, autodeterminazione, relazioni interpersonali, inclusione sociale, diritti, benessere emotivo, benessere fisico, benessere materiale), **condizioni facilitanti** (ad es: flessibilità, continuità, competenza) e **relazioni di sostegno** (ad es: rispetto, affidabilità, capacità di risposta) (AAIDD 2022, p.75)

I Sistemi di sostegno

- I sistemi di sostegno sono una **rete interconnessa di risorse e strategie** che promuovono lo sviluppo e gli interessi di una persona e migliorano il **funzionamento e il benessere personale** di un individuo. I sistemi di sostegno efficaci **sono centrati sulla persona**, **completi**, **coordinati** e **orientati agli esiti** (AAIDD 2022, p.73)
- Ci sono delle scale di valutazione dell'entità dei sostegni che una persona necessita, la SIS (Supports Intensity Scale, 2004)

- Il paradigma dei sostegni si fonda sulla premessa che:

(a) la differenza più rilevante tra le persone con DI e la popolazione generale è che le prime necessitano di diversi tipi e intensità di sostegni per partecipare pienamente alla società e contribuire ad essa

(b) (b) i sostegni riducono (compensano, migliorano) l'impatto della disabilità ma non la eliminano (AAIDD 2022, p.74)

Il ruolo dell'operatore sociale

- *"(…) il nuovo paradigma dei sostegni (…) sposta l'attenzione dal "prendersi cura dell'individuo coi i suoi deficit" all'investire tempo e impegno per promuovere reti di sostegno in qualsiasi ambiente nel quale la persona voglia o abbia necessità di stare…" (Cottini, 2026, p.140).*

Ripresa concetti:
La zona di sviluppo prossimale secondo Vygotskij

Scaffolding

- Questo termine creato da Wood, Brune e Ross nel 1976 significa **«creare un impalcatura»** e definisce il sostegno fornito da chi è più esperto (genitori, educatori, insegnanti, ecc), che orienta senza dirigere e che aiuta a risolvere un problema, permettendo l'acquisizione di nuove competenze.

- Come educatori dobbiamo ricordarci di non sostituirci alla persona, ma di essere di sostegno, sempre attenti a valutare il nostro intervento permettendo alla persona di essere al centro dei propri apprendimenti.

Bibliografia

- AAIDD (2022), Disabilità intellettiva; Definizione, diagnosi, classificazione e sistemi di sostegno, 12° edizione, Edizione italiana a cura di Serafino Buono e Luigi Croce

- Cottini, L. (2016) L'autodeterminazione nelle persone con disabilità, Erickson